

CAPÍTULO 14.22

Enfermedades Reumatológicas en Niños

PERFIL EUNACOM 1.14.22

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción al Enfrentamiento Reumatológico Pediátrico

El estudio de las enfermedades reumatológicas en la infancia requiere un cambio de paradigma respecto a la medicina del adulto. No se trata simplemente de "adultos pequeños", sino de un grupo etario con patologías exclusivas y presentaciones atípicas de enfermedades conocidas.

- El enfrentamiento debe dividirse en dos grandes grupos:
- Enfermedades típicas de la infancia:** Patologías autoinmunes o autoinflamatorias que se ven casi exclusivamente en niños.
- Enfermedades del tejido conectivo del adulto con presentación pediátrica:** Patologías clásicas del adulto que, aunque menos frecuentes, pueden debutar en la niñez.

1. Enfermedades Típicas de la Infancia

Estas patologías constituyen el núcleo de la reumatología pediátrica y suelen ser motivo frecuente de consulta en servicios de urgencia y pediatría general.

- Artritis Idiopática Juvenil (AIJ):** Anteriormente conocida como Artritis Reumatoide Juvenil. Es la causa más común de artritis crónica en niños.
- Púrpura de Schoenlein-Henoch (Púrpura por IgA):** La vasculitis más frecuente en la infancia, caracterizada por púrpura palpable no trombocitopénica, dolor abdominal y compromiso renal.
- Enfermedad de Kawasaki:** Una vasculitis de medianos vasos con predilección por las arterias coronarias. Es una causa importante de cardiopatía adquirida en niños.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el adulto existe una variante de la AIJ sistémica conocida como **Enfermedad de Still del adulto**, pero su presentación más característica y frecuente ocurre en la edad pediátrica.

2. Enfermedades del Tejido Conectivo en Niños

Es un error común pensar que enfermedades como el Lupus o la Dermatomiositis son exclusivas de adultos. En pediatría, estas enfermedades suelen ser **más agresivas** y requieren un alto índice de sospecha.

TABLA 14.22.1: ENFERMEDAD VS CONSIDERACIÓN EN PEDIATRÍA

ENFERMEDAD	CONSIDERACIÓN EN PEDIATRÍA
Lupus Eritematoso Sistémico (LES)	Suele presentarse con mayor compromiso renal y hematológico que en el adulto.
Dermatomiositis Juvenil	Presenta las clásicas pápulas de Gottron y eritema en heliotropo, pero con mayor frecuencia de calcinosis cutánea.
Esclerodermia Infantil	En niños es más frecuente la forma localizada (Morfea) que la sistémica.
Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo	Presentación similar al adulto, con presencia de anticuerpos anti-U1-RNP.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca descartes una enfermedad autoinmune sistémica en un niño solo por su edad. Si el cuadro clínico es sugerente (ej. debilidad muscular proximal y rash heliotropo), el diagnóstico sigue siendo el mismo que en el adulto.

3. El Caso Especial del Síndrome de Sjögren Juvenil

El **Síndrome de Sjögren** en niños es una entidad que suele confundir al clínico debido a que su presentación clínica difiere radicalmente de la

del adulto.

- En adultos:** Predomina el "Síndrome Sicca" (ojo seco y boca seca).
- En niños:** La manifestación clínica más característica es la **parotiditis recurrente**.

NOTA CLÍNICA

La **parotiditis recurrente** en niños tiene múltiples etiologías (incluyendo la idiopática, que es la más frecuente). Sin embargo, ante cuadros repetitivos de aumento de volumen parotídeo bilateral, se debe realizar el estudio inmunológico para descartar Sjögren.

4. Principios del Diagnóstico y Manejo

Aunque los criterios diagnósticos (como los de la ACR/EULAR para Lupus) son bastante similares a los del adulto, en pediatría se debe poner especial énfasis en el **crecimiento y desarrollo**.

Claves del examen físico:

1. **Evaluación articular:** Buscar aumento de volumen, calor local y limitación del rango articular (muchas veces el niño no refiere dolor, sino "rigidez matinal"). 2. **Examen cutáneo:** Buscar activamente rash malar, lesiones purpúricas, nódulos o cambios en la coloración distal (Fenómeno de Raynaud). 3. **Curva de crecimiento:** Las enfermedades inflamatorias crónicas suelen estancar la talla y el peso del paciente.

Laboratorio Inicial Sugerido:

- Hemograma con VHS (la anemia de enfermedades crónicas y la elevación de reactantes de fase aguda son la regla). - Perfil bioquímico y orina completa (búsqueda de proteinuria o sedimento activo). - Anticuerpos antinucleares (ANA): Útiles como tamizaje, pero recordando que un ANA (+) aislado no hace diagnóstico de enfermedad.

Resumen de Perlas para el EUNACOM

- AIJ:** Se define por artritis de ≥ 1 articulación, de duración ≥ 6 semanas, en menores de 16 años, descartando otras causas.
- Kawasaki:** Siempre sospechar ante fiebre de ≥ 5 días que no cede con antibióticos, asociada a inyección conjuntival, cambios en mucosas y extremidades.
- Sjögren Infantil:** Pensar en él ante una **parotiditis recurrente** no infecciosa.
- Manejo General:** El tratamiento suele iniciarse con AINEs y corticoides, pero la derivación precoz al reumatólogo infantil es obligatoria para el inicio de fármacos modificadores de la enfermedad (DMARDs) o biológicos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que la **Púrpura de Schoenlein-Henoch** suele tener el antecedente de una infección respiratoria alta 1 a 3 semanas antes del inicio de los síntomas cutáneos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 7 años con parotiditis recurrente bilateral. ¿Qué enfermedad reumatológica debe considerarse en el diagnóstico diferencial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedades Reumatológicas en Niños. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Enfermedades típicas de la infancia: artritis juvenil idiopática, púrpura de Schönlein-Henoch, enfermedad de Kawasaki
- Todas las enfermedades del tejido conectivo tienen variante pediátrica (lupus, dermatomiositis, esclerodermia, EMTc, Sjögren)
- Las variantes pediátricas son muy similares a las del adulto con criterios semejantes
- Excepción: Sjögren infantil se manifiesta como parotiditis recurrente (no síndrome de sicca)
- No olvidar que los niños también pueden tener enfermedades reumatológicas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS EN NIÑOS)**PREGUNTA 1**

Niño de 7 años con parotiditis recurrente bilateral. ¿Qué enfermedad reumatológica debe considerarse en el diagnóstico diferencial?

- A)** Lupus eritematoso sistémico
- B)** Síndrome de Sjögren
- C)** Artritis juvenil idiopática
- D)** Dermatomiositis
- E)** Enfermedad de Kawasaki

PREGUNTA 2

Niña de 10 años con debilidad proximal, CK elevada y rash heliotropo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Artritis juvenil idiopática
- B)** Lupus eritematoso sistémico infantil
- C)** Dermatomiositis infantil
- D)** Fibromialgia
- E)** Miositis por cuerpos de inclusión

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes enfermedades reumatológicas es típicamente de la infancia?

- A)** Polimialgia reumática
- B)** Esclerodermia difusa
- C)** Enfermedad de Kawasaki
- D)** Síndrome antifosfolípido
- E)** Arteritis de células gigantes

RESUMEN: ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS EN NIÑOS

Esta clase aborda el enfoque de las enfermedades reumatológicas en la edad pediátrica. Existen enfermedades típicas de la infancia como la artritis juvenil idiopática, la púrpura de Schönlein-Henoch y la enfermedad de Kawasaki, que se ven en sus propias clases. Además, las enfermedades autoinmunes del adulto (lupus, dermatomiositis, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren) tienen variantes pediátricas que son muy similares a las del adulto. Lo más importante es recordar que los niños también pueden tener enfermedades reumatológicas. Los criterios no siempre son iguales pero son bastante similares. La excepción relevante es el síndrome de Sjögren infantil, que se manifiesta como parotiditis recurrente en vez del síndrome de sicca clásico del adulto. La parotiditis recurrente tiene múltiples causas (la idiopática es la más frecuente), pero el Sjögren es una de ellas.